Sujet n°1 : SDD 147

Spécialité : ORL

Date : 26 octobre 2023
Auteur : Elisa Durand (DES d'ORL - Promotion ECN 2023)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (DES de médecine interne - Promotion ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Annonce/information du patient
Item(s) en lien avec la station	Item 147 Epistaxis
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 147 Epistaxis
Matériel nécessaire à la station	Table de consultation, chaise
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne aux urgences et vous recevez M. Cavendish (40/60 ans) qui se présente aux urgences car il saigne du nez depuis 1h sans s'arrêter.
Il a pour antécédents : allergie aux poils de chat et appendicite dans l'enfance. Il prend des antihistaminiques ponctuellement.
Le patient a déjà effectué une compression bi digitale sans succès.

Votre externe a déjà interrogé et examiné le patient.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Interroger l'externe à la recherche des signes de gravité
- Expliquer à l'externe la 1ere ligne de traitement que vous souhaitez mettre en place

Vous ne devez pas :

- Vous ne devez pas réaliser d'interrogatoire poussé
- Vous ne devez pas réaliser la procédure de traitement

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec personnel de santé standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Vérifie que le patient est installé en position assise ou demi-assise	1 pt
2.	Recherche une tachycardie	1 pt
3.	Recherche une hypotension	1 pt
4.	Recherche une mauvaise tolérance de l'hémorragie : au moins 3 - polypnée - désaturation - temps de recoloration cutanée >3sec - pâleur - sueurs - marbrures - agitation - troubles de la conscience	1 pt
5.	Recherche l'abondance du saignement	1 pt
6.	Recherche la répétition des épisodes	1 pt
7.	Recherche des télangiectasies sur le visage orientant vers une maladie de Rendu-Osler	1 pt
8.	Explique à l'externe qu'il va devoir se moucher et se laver le nez au sérum physiologique une nouvelle fois	1 pt
9.	Explique à l'externe qu'il va bénéficier d'une anesthésie locale.	1 pt
10.	Explique à l'externe qu'il va bénéficier d'une antalgie par voie orale de palier 1 ou 2 selon sa douleur	1 pt
8.	Explique à l'externe qu'une mèche sera rentrée par la narine puis tassée jusqu'au fond de la fosse nasale	1 pt
9.	Explique à l'externe que si le méchage reste plus de 48h une antibioprophylaxie sera prescrite	1 pt

10.	Explique à l'externe que la technique s'appelle un "tamponnement antérieur"	1 pt

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

TOTAL :	/15

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

Ce qui me semble important à retenir :
=> les signes de gravités +++ ils conditionnent la suite de la prise en charge, si ils sont présent il faudra d'abord conditionner le patient avec 1 voire 2 VVP, un monitoring, +/- oxygénothérapie et hospitalisation en USI, il faudra aussi prévoir un bilan biologique (NFS = retentissement de l'hémorragie, plaquette/TCA/TP/INR(si AVK) = troubles de l'hémostase, bilan pré transfusionnel (groupe ABO, Rhésus, RAI))

=> retenir les grandes lignes d'un tamponnement antérieur, ça implique le patient dans sa prise en charge car il comprend ce qu'on va lui faire. Toujours penser à l'antalgie/anxiolyse du patient, ça permet de rendre l'expérience moins douloureuse pour le patient et ça renforce le lien de confiance.

=> ATTENTION, il est INNACCEPTABLE de laisser un patient avec une épistaxis couché, il y un fort risque d'inhalation !!!!!!

=> Bien que le patient soit couché/demi assis/assis, l'étudiant s'est mis à sa hauteur grâce à la chaise mise à disposition ou en montant/descendant la table. Ce genre de comportement peut vous rapporter des points dans la partie comportement et communication non verbale !

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le candidat est interne aux urgences, il reçoit Mr CAVENDISH (40/60ans) pour un saignement de nez depuis 1h. Le patient a déjà essayé la compression bidigitale sans succès, il est un peu stressé mais pas agité.

Plan de la station ECOS :

- Le patient simulé est <u>allongé</u> sur la table d'examen avec un mouchoir près du nez
- Une chaise est mise à disposition dans le box
- Le candidat rentre, se présente et s'avance vers le PSS
- Il doit interroger l'externe à la recherche de signes de gravité, à la recherche de signes de gravité de l'épistaxis (mauvaise tolérance du saignement, tachycardie, hypotension, abondance du saignement, atcd/signes de la maladie de rendu osler.

- Si l'étudiant demande les signes de pancartes type pression artérielle et fréquence cardiaque, l'examinateur pourra lui remettre une copie du scope

- Après avoir noté qu'il n'y avait aucun signe de gravité, le candidat doit expliquer la procédure du tamponnement

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

- Dès l'entrée du candidat, demander : « Bonjour, je suis allé voir M.CAVENDISH en box 2, je peux t'en parler ? "

Identité du patient :

Mr CAVENDISH, homme entre 40/60 ans, 1m85 pour 78kg

Mode de vie :

Mr CAVENDISH est professeur d'anglais, il est marié, sans enfants, il ne boit pas, il ne fume pas, il est allergique aux poils de chat, sa femme ne l'accompagne pas.

Comportement global :

Mr CAVENDISH est un peu stressé parce que ça fait maintenant 1h qu'il saigne du nez, il n'a jamais eu ça, ça l'inquiète un peu. Il n'est pas agité et n'a pas de troubles de conscience
Le PSS au cours de l'examen n'est pas agité et ne présente pas de troubles de conscience.

Antécédents personnels :

Appendicite dans l'enfance
Allergie aux poils de chat

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Antihistaminiques ponctuellement

Symptômes positifs :

Si l'étudiant demande : « est-ce que vous avez des sueurs », le PS répond qu'il n'en a pas

- Si l'étudiant demande si le PS est pâle ou présente des marbrures, le PSS pourra lui donner les photos en données complémentaires

- Si l'étudiant demande si le patient à des télangiectasies, le PSS pourra lui donner les photos fournies en données complémentaires

- Si l'étudiant demande l'abondance du saignement, le PSS peut répondre que : ça goutte continuellement de la narine droite depuis 1h et qu'il pourrait quantifier ça comme une petite tasse à café

Constantes :

Fréquence cardiaque : 80 BPM, TA : 120/70 mmHg FR: 14/mins

Donnée complémentaire :

Photo 1 : A remettre si l'étudiant demande si le PS à des marbrures

Photo 2 : A remettre si l'étudiant recherche une pâleur conjonctivale (photo normale)

Photo 3 : à remettre si l’étudiant recherche des télangiectasies

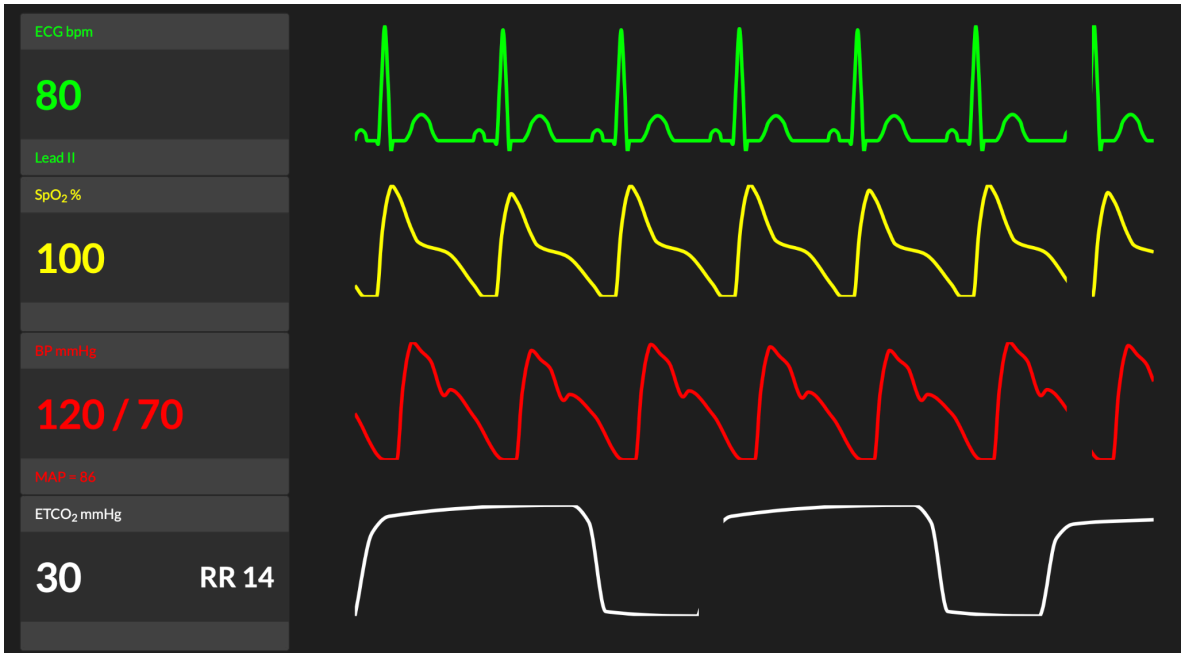

Photo 4 : scope du patient

Sources images : oeil => https://fr.dreamstime.com/photo-macro-cornée-normale-saine-d-oeil-humain-équipe-examinent-des-cils-myopie-prévoyance-ophtalmologie-clinique-image207837118
jambes => https://fr.dreamstime.com/jambes-velues-d-homme-image102400886
Bouche => j’ai pas retrouvé
Scope => https://resusmonitor.com/sim_monitor (grave cool ce site)

Questions de relance :

Quand l’étudiant parle de tamponnement antérieur, dites lui que le patient vous a fait part du fait qu’il avait peur d’avoir mal et qu’il ne voudrait surement pas faire le geste si celui ci était trop douloureux

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Documents présents dans la station :

- Si besoin, scénario sur papier
- Barème sur papier si besoin
- Document à fournir à l'étudiant pour les signes physiques + PA et bpm